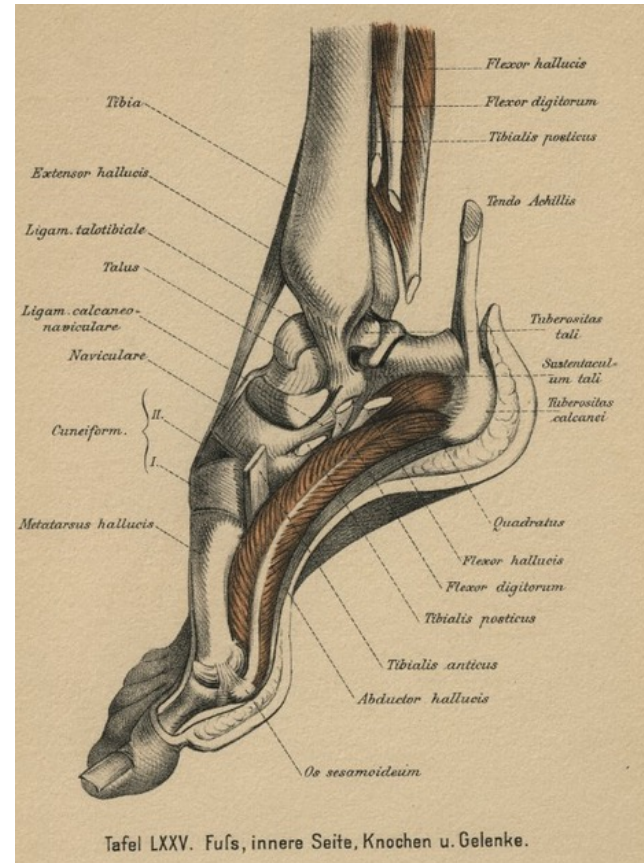
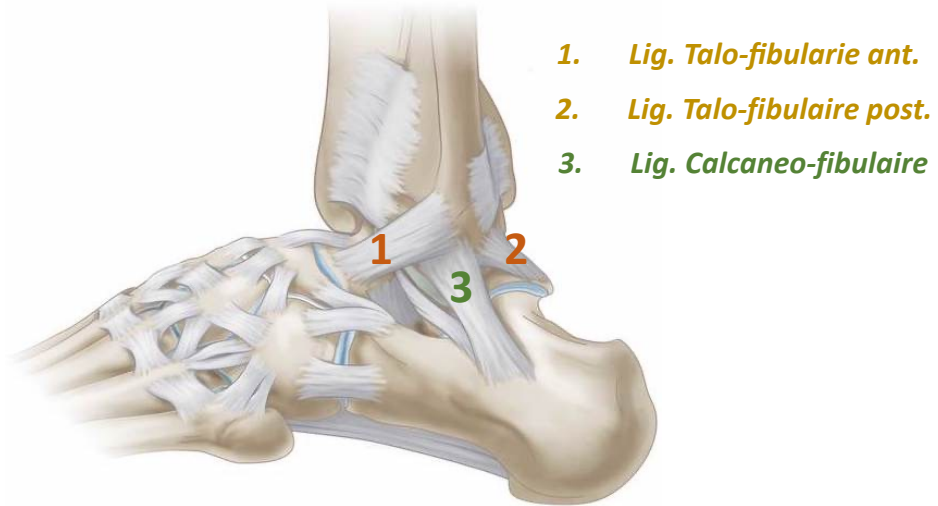


## Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



## Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques

### Entorse de cheville : Testing ligamentaire



Test du tiroir antérieur  
*Lig. talofibulaire ant*



Talar tilt test (stress varus)  
*Lig. calcaneofibulaire*



## Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques

### Fasciite plantaire : test de Windlass

- En effectuant une extension du gros-orteil, on met sous tension le **fascia plantaire** en l'étirant (insertion au niveau du calcaneum jusqu'au bout des orteils) : Si la manœuvre induit une douleur au niveau du calcaneum médial (site d'insertion proximal du fascia), le test est positif



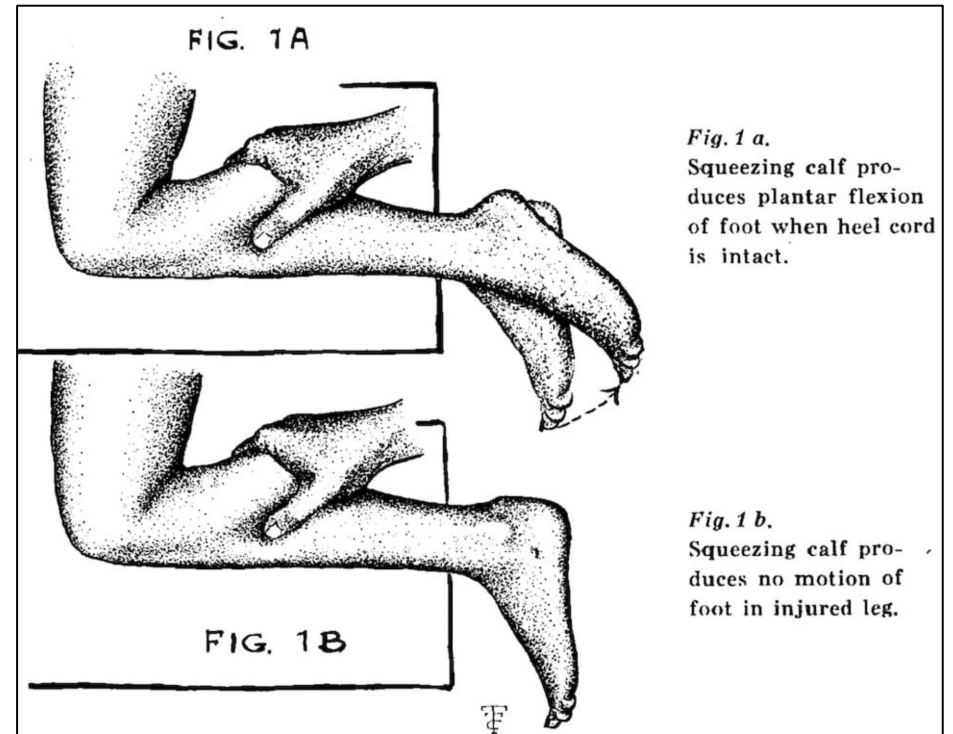
Insertion du fascia plantaire sur le calcanéum



Idéalement, les orteils sont « dans le vide »

### Rupture tendon d'Achille: test de Thompson

- Normalement, la compression du mollet conduit à une flexion plantaire du pied. Abolite en cas de lésion tendineuse

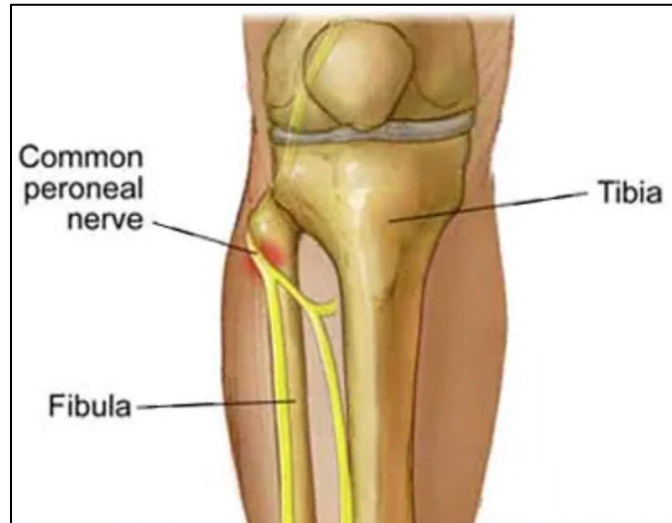
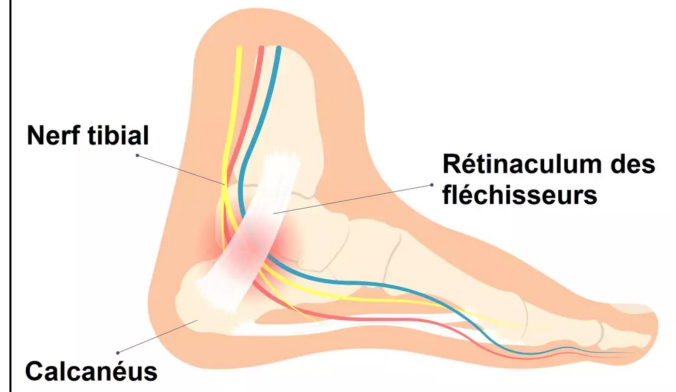


## Cheville-pieds : Rappel des test spécifiques

### Mononeuropathie périphérique: test de Tinel

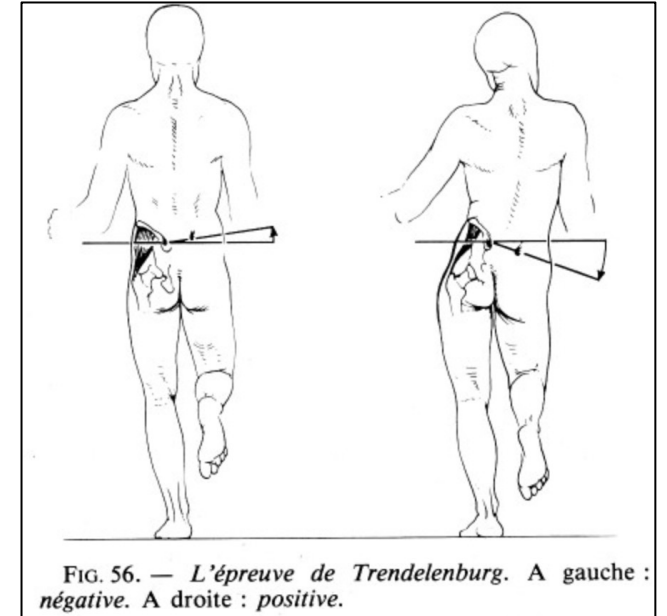
- Nerf fibulaire commun : percussion juste en dessous de la **tête de la fibula**
- Nerf tibial postérieur : percussion en dessous de la malléole médiale (**rétinaculum fléchisseur**)

#### NERF TIBIAL

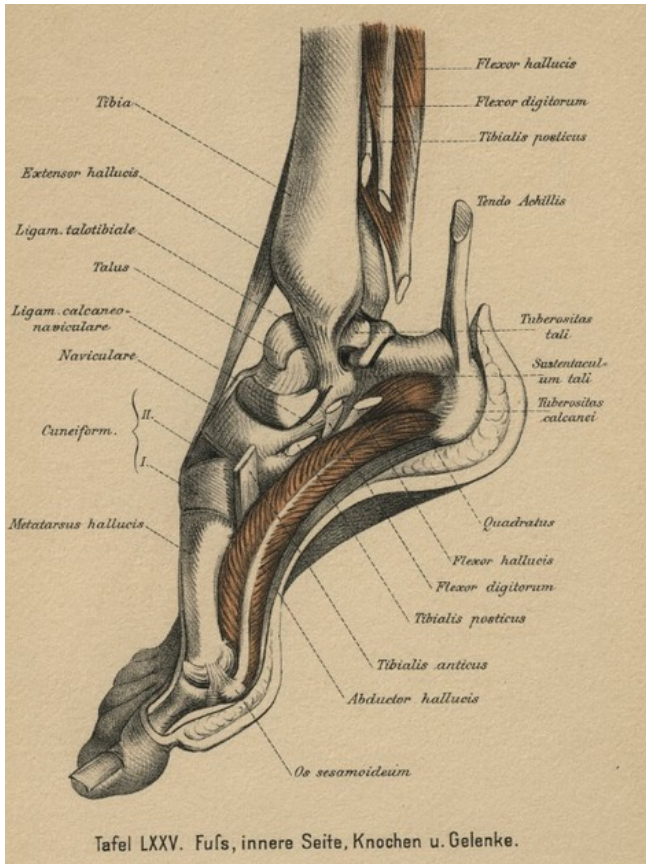


### Mononeuropathie périphérique: Trendelenburg

- En présence d'un pied tombant, permet de distinguer une atteinte proximale (radiculopathie L5) avec une atteinte du **moyen fessier**, d'une atteinte distale (compression du nerf fibulaire commun, test normal)







### Fracture jambe:

- **Définition :** Les fractures du **tibia** et de la **fibula** sont les fractures des os long les plus fréquentes. Elles peuvent être proximales (au niveau du plateau tibial), ou distal. Vu la faible épaisseur de peau au-dessus des os, il y a un risque important de fracture ouverte, d'infection de plaie et de dégât neuro-vasculaire.
- **Cliniques:** Signes généraux de fractures -> rougeur, œdème, douleurs ; déformité et palpation d'une encoche à la surface osseuse ; crépitation osseuse (lorsque deux parties d'un os fracturé entrent en contact) ; visualisation d'un fragment d'os à la surface de la peau.
- **Diagnostique:** Visible à la radiographie
- **Traitement :** Conservateur ou chirurgical (en cas de fracture ouverte ou déplacé de la diaphyse)

### Fracture cheville :

- **Définition :** Fracture au niveau de la **malléole interne, externe** ou de la **partie postérieure du tibia distal**.
- **Cliniques:** Les **critère de Ottawa** permettent de suspecter une fracture associée aux entorses de la cheville (voir slide suivante)  
Signes généraux de fractures -> rougeur, œdème, douleurs ; déformité et palpation d'une encoche à la surface osseuse ; crépitation osseuse (lorsque deux parties d'un os fracturé entrent en contact) ; visualisation d'un fragment d'os à la surface de la peau.
- **Diagnostique:** Visible à la radiographie (antéro-postérieur et oblique)
- **Traitement :** Conservateur ou chirurgical (en cas d'instabilité).  
En général conservateur en cas de fracture isolée de la malléole (interne ou externe ou de la partie postérieure du tibia).

Fracture cheville :  
**Malléole latérale**

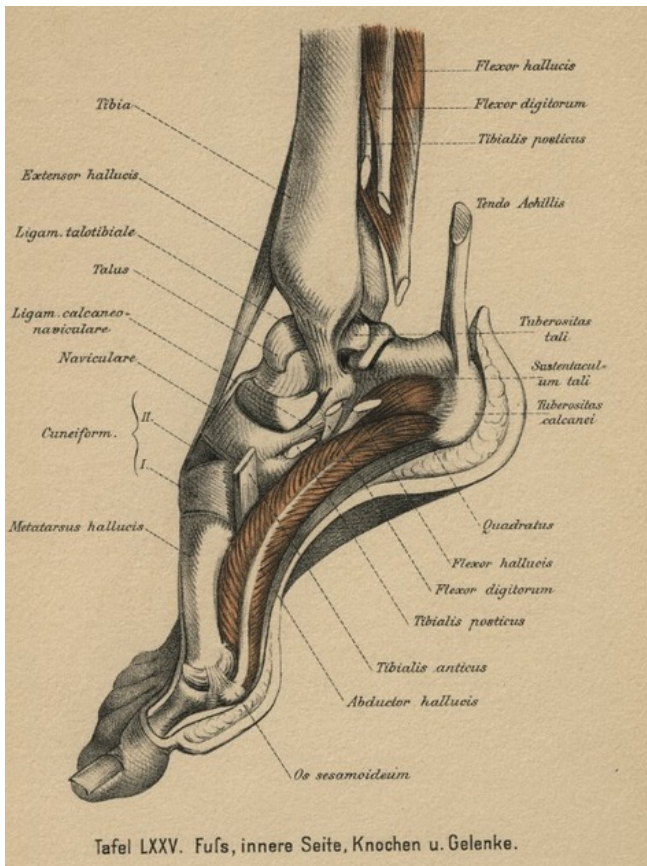


Fracture cheville :  
**Partie postérieure tibia**



Fracture cheville :  
**Bi-maléolaire**





### Entorse de la cheville :

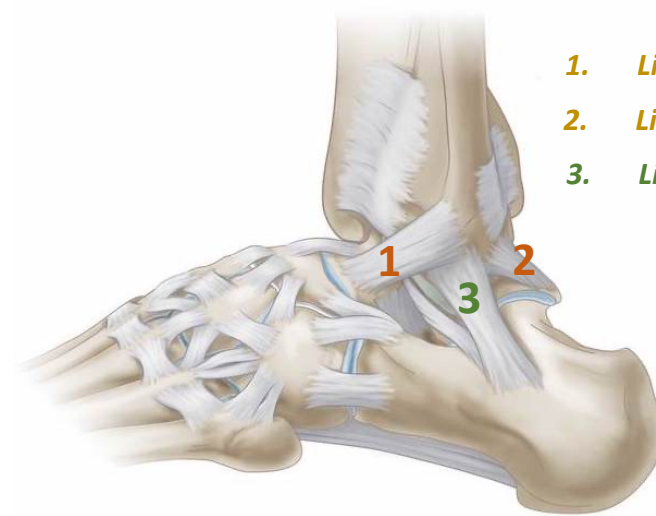
- **Définition :**
  - **Entorse en supination :** Atteinte du complexe ligamentaire **latéral** de la cheville (ligaments **talo-fibulaire ant/post** et **calcaneo-fibulaire**) lors d'un trauma avec inversion et adduction. Le ligament talo-fibulaire antérieur (LTFA) est le plus souvent touché.
  - **Entorse en pronation :** Atteinte du complexe ligamentaire médial de la cheville (**ligament deltoïde**) lors d'un trauma avec inversion et adduction. Beaucoup moins fréquent que les lésions du complexe latéral.
- **Cliniques:** Œdème, douleurs, rougeurs, limitation de l'amplitude articulaire. **Tiroir antérieur** et **Talar Tilt Test**
- **Diagnostic, marche à suivre:** Anamnèse basé sur l'histoire et l'examen clinique. Vérifier l'intégrité vasculaire et nerveuse distale. Évaluer la nécessité d'effectuer une radio basé sur les **critères de Ottawa**.
- Ottawa : **effectuer une radio si...**
  - ... Le patient ne supporte pas la mise en charge immédiatement après son trauma ou s'il est incapable de faire 4 pas
  - ... Douleur à la palpation : malléoles interne/externe (zone sur 6 cm), base du 5<sup>e</sup> métatarsien (latéralement), os naviculaire (médialement)
- **Traitement :**
  - **Conservateur :** Le plus souvent ! **Immobilisation, glace**, élévation et **délestage** de l'articulation. Immobilisation par bandes élastiques ou orthèse avec sangle, voir attelle plâtrée. L'immobilisation durera de quelques jours à quelques semaines, en fonction du grade et de l'évolution.
  - **Chirurgical :** Rarement lors d'atteinte latérale, plus souvent si lésions ligamentaire médiale

### Rupture du tendon d'Achille :

- **Définition :**

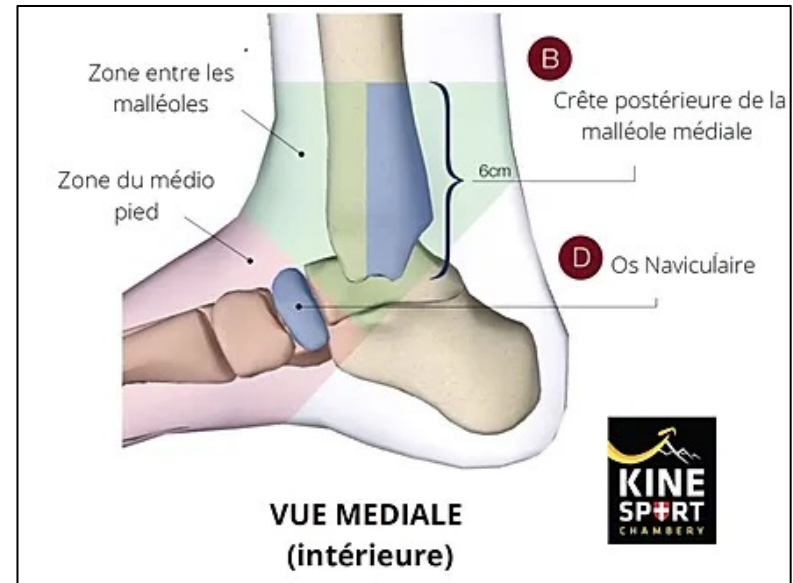
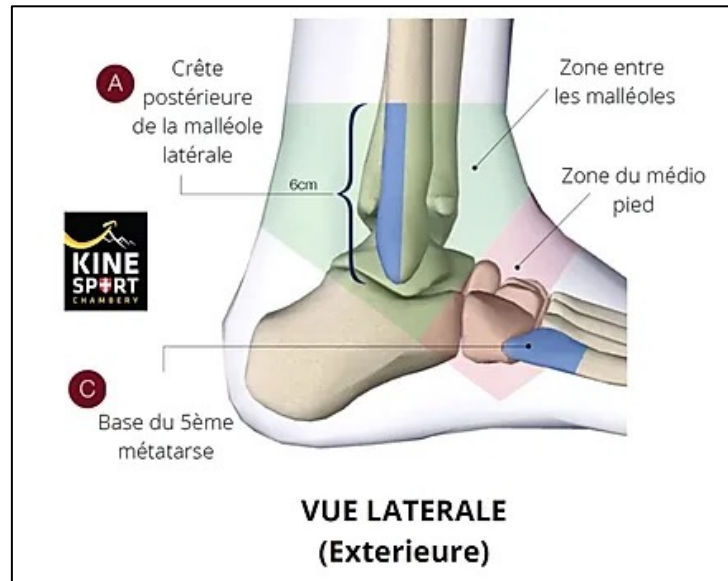
Survient en général au cours d'une activité physique ou après un traumatisme, chez des hommes entre 30-50 ans.

FR : Certains médicaments (**fluoroquinolones**, glucocorticoïdes...), tendinopathie Achilléenne sous-jacente
- **Cliniques:** Très typique, avec une douleur soudaine intense accompagné d'un claquement semblable à une **détonation**
- **Diagnostic :** Une anamnèse et un **test de Thompson** positif font fortement suspecter la pathologie, et un **US** du tendon devrait être effectué en première intention. L'IRM permet de confirmer définitivement la rupture et une radiographie permet d'exclure des fractures.
- **Traitement :** Conservateur ou chirurgical, les deux sont possibles. La chirurgie diminue plus de le risque de récurrence, mais avec des risques inhérent au geste (infection, hémorragie...).

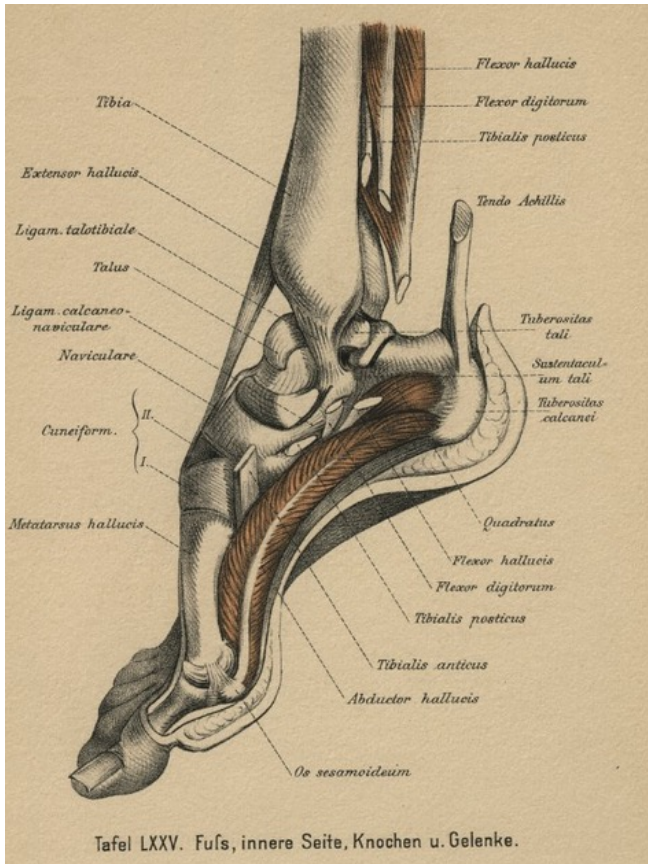


1. *Lig. Talo-fibulaire ant.*
2. *Lig. Talo-fibulaire post.*
3. *Lig. Calcaneo-fibulaire*

### Critère d'Ottawa:







### Metatarsalgie :

- **Définition :** Douleurs mécanique au niveau de la tête des **métatarses II-IV**, le plus souvent causé par une l'atrophie du tissus conjonctif plantaire chargé de protégé les os lors de la charge. Bénin et fréquent, surtout avec l'âge ou l'utilisation de chaussure inadaptées.
- **Cliniques:** Douleurs en regard de la tête des métatarses II-IV provoqué par la palpation ou lors de la marche. Soulagé par la décharge.
- **Diagnostic:** Clinique uniquement.
- **Traitement :** **Semelles** et **activités adaptées**. Très rarement, opération avec ostéotomie des os touchés.

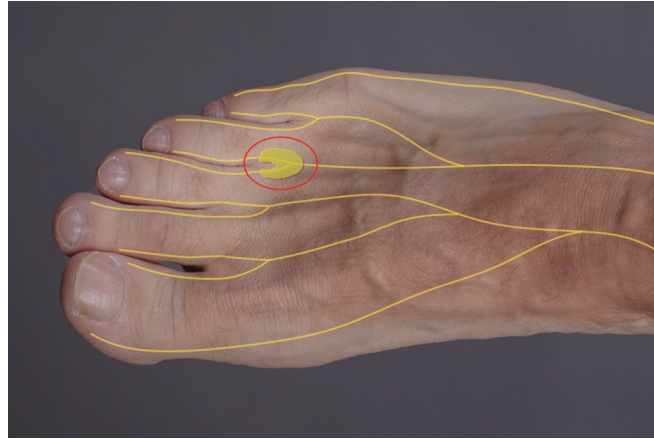
### Névrome de Morton :

- **Définition :** Syndrome canalaire causant une **irritation d'un nerf plantaire**, le plus souvent entre les **métatarses 2-3 ou 3-4**. Avec l'irritation mécanique, il peut se passer une fibrose péri-neurale (faussement appelée « névrome »). Nette prédominance féminine (>80% des cas).
- **Cliniques:** Douleurs neuropathiques irradiant dans les oreilles et la face plantaire du pieds accompagné de paresthésie et parésie, reproduite par la palpation (bord supérieur du pied)
- **Diagnostic:** Uniquement clinique ! La réponse l'injection d'anesthésique locaux (± cortisone) permet de conforter l'hypothèse. Une lésion est parfois visible à l'IRM, mais l'examen manque de sensibilité et de spécificité et n'est pas indiquée.
- **Traitement :** **Injection d'anesthésique locaux ± cortisone** au besoin. En cas d'échec, possibilité de traiter chirurgicalement le syndrome canalaire.

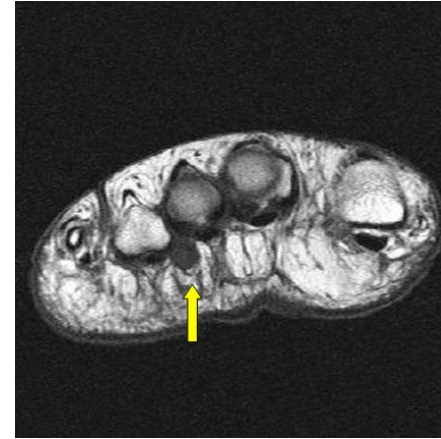
### Fasciite plantaire:

- **Définition :** Dégénérescence et inflammation du fascia plantaire, bilatérale dans environ 30% des cas. Pic d'incidence entre 40-60 ans, touche 10% de la population à un moment ou l'autre de sa vie.
- **FR :** Surpoids, sédentarité, stress mécanique répété et à haute intensité
- **Cliniques:** Douleurs de la plante du pieds, sans irradiation. Pire au levé et après une longue période d'inactivité mais s'améliore progressivement au fil de la journée et revient en dans la soirée. **Sensibilité à la palpation du fascia plantaire**, en particulier au niveau de l'insertion du fascia plantaire sur le **calcaneum** (partie médiale et plantaire du talon). Le **test de Windlass** est très spécifique mais peu sensible (30%). Il est positif lorsque la dorsiflexion du grand orteil provoque des douleurs au niveau de l'insertion du fascia.
- **Diagnostic:** Généralement clinique, les imageries serviront surtout à exclure un DD (ie fracture du calcaneum). On peut retrouver une **épine calcanéenne** (pas toujours), un épaissement du fascia et un œdème à l'insertion du fascia sur le calcaneum.
- **Traitement :** **Exercice de stretching du fascia**, si nécessaire **AINS**, éviter les **chaussures** non adaptées (claquette, chausson de danse...). Cave : Il ne faut pas aller enlever chirurgicalement l'épine calcanéenne !

**Névrome de Morton**



**Névrome de Morton**

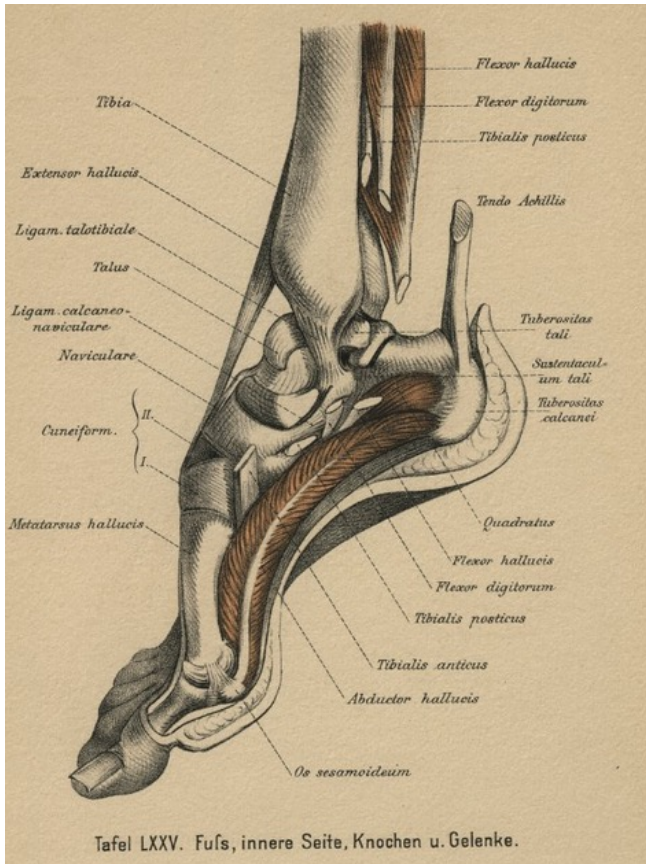


**Épine calcanéenne**



**Insertion du fascia plantaire sur le calcanéum et test de Widlass**





### Syndrome de compression du nerf fibulaire commun :

- **Définition :** Syndrome canalaire le plus fréquent au membre inférieur. Il fait suite à une compression du nerf fibulaire commun au niveau de la tête de la fibula (passage du nerf juste en dessous). Le plus souvent, la compression est secondaire au **maintient prolongé d'une posture accroupie** (carreleurs, vendeurs de chaussures...). Rarement, la compression est secondaire à un kyste poplité.
- **Cliniques :** Atteinte souvent purement motrice des muscles de la **loge antérieure** (muscles tibial antérieur, extenseurs des orteils et de l'hallux) et **latérale** (muscles long et court fibulaire) de la jambe. **Pas d'atteinte du moyen fessier** (pas de **Trendelenburg**), permet d'écarter une radiculopathie **L5**. Parfois (mais pas toujours) accompagné de troubles sensitifs au niveau de la partie latérale de la jambe et le dos du pied.
- **Diagnostic :** Avant tout clinique, un **test de Tinel** positif et des atteintes motrices compatibles est très évocateur. L'ENMG permet de confirmer le diagnostic et une imagerie (radiographie : fracture tête fibula, IRM : Kyste) permettra de guider la prise en charge.
- **Traitement :** Conservateur (Orthèse, injection de glucocorticoïde, rééducation) ou chirurgical (excision de kyste) en fonction de la cause

### Tunnel tarsien :

- **Définition :** Compression du nerf tibial postérieur au niveau du rétinaculum des fléchisseurs des orteils. Les causes les plus fréquentes sont **post-traumatiques** (lésions de la malléole médiale, du talus ou du calcaneum, l'arthrite rhumatoïde et l'arthrose (**ostéophytes**) ou d'autres masses (kystes, tumeurs).
- **Cliniques :** Atteinte sensitive (douleurs neuropathiques, hypoesthésie...) dans le talon, la plante des pieds et les orteils. Parfois déficit moteur dans les muscles intrinsèques (fléchisseurs orteils) .
- **Diagnostic :** Clinique, un **test de Tinel** positif la percussion du rétinaculum des fléchisseurs est fortement évocateur, du même qu'une douleur reproductible à l'éversion avec dorsiflexion du pied. Un ENMG permettra de mettre en évidence une diminution de la vitesse de conduction dans les branches terminales du nerf tibial postérieur (nerfs plantaires médial et latéral).
- **Traitement :** Dans un premier temps conservateur (**repos, AINS, orthèse**). Si nécessaire, injection de glucocorticoïdes voir chirurgie.